

Кузнецов В.В.¹, Косилов К.В.²

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТАТУСА НА УСПЕВАЕМОСТЬ У РОССИЙСКИХ И КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

¹ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 690002, Владивосток;

²ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 690922, Владивосток

♦ Цель исследования — анализ взаимосвязи семестровой успеваемости с уровнем самооценки психологических характеристик качества жизни, связанного со здоровьем и факторами социально-экономического статуса у российских и китайских студентов медицинских специальностей сопредельных территорий Дальнего Востока. Исследование проводилось с 01.12. 2017 по 15.05.2019 года в Школе Биомедицины Дальневосточного Федерального Университета (ШБМ ДВФУ), Тихоокеанском Государственном медицинском университете (ТГМУ) Российской Федерации, медицинских факультетах Харбинского и Муданьцзянского университетов (КНР). В нем приняли участие 316 российских и 302 китайских студента (всего - 618 человек с равным гендерным представительством), средний возраст - 21,6 лет. Средняя частота отклика составила 92, 8%.

Студенты, принявшие участие в исследовании, заполняли стандартизированную анкету «Краткая форма самооценки качества жизни, связанного со здоровьем MOS SF-36» (MOS SF - Medical Outcomes Study-Short Form). Изучение психического статуса проводилось с использованием шкал жизнестойкости (ЖС), социального функционирования (СФ), эмоционального статуса (ЭС), психологического комфорта (ПК). Исследование социально-экономического статуса проводилось по Анкете Поздеевой (2008) с дополнениями авторов.

В результате исследования было установлено, что уровень самооценки психологического компонента качества жизни, связанного со здоровьем у российских и китайских студентов медицинских направлений находится в пределах диапазона нормативных значений; российские студенты-медики выше оценивают уровень психологического комфорта, в то время как их китайские сверстники дают более высокую оценку собственному социальному функционированию и жизнестойкости. У студентов обоих выборок отмечается высокий уровень корреляции психологического компонента качества жизни, связанного со здоровьем с успеваемостью. Кроме того, в обеих выборках уровень успеваемости коррелирует с оценками условий обучения и проживания, а также отдельными характеристиками психологического статуса.

Ключевые слова: психологический компонент качества жизни; студенты; Россия; Китай; заболеваемость; успеваемость; социально-экономический статус.

Для цитирования: Кузнецов В.В., Косилов К.В. Сравнительный анализ влияния психологических характеристик качества жизни и социально-экономического статуса на успеваемость у российских и китайских студентов медицинских специальностей сопредельных территорий Дальнего Востока. *Российский медицинский журнал*. 2019; 25(5-6): 287-292.
DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-5-6-287-292>

Для корреспонденции: Косилов Кирилл Владимирович, доктор мед. наук, профессор департамента Социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного Федерального университета. 690922, Владивосток,
E-mail: oton2000@mail.ru

Kuznetsov V.V., Kosilov K.V.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE QUALITY OF LIFE AND SOCIO-ECONOMIC STATUS ON ACADEMIC PERFORMANCE OF RUSSIAN AND CHINESE STUDENTS OF MEDICAL SPECIALTIES IN THE ADJACENT TERRITORIES OF THE FAR EAST

¹Pacific State Medical University, 690002, Vladivostok, Russian Federation;

²Far Eastern Federal University, 690922, Vladivostok, Russian Federation

♦ The purpose of the study is to analyze the relationship of semester performance with the level of self-assessment of the psychological characteristics of quality of life related to health and factors of socio-economic status in Russian and Chinese students of medical specialties in the neighboring territories of the Far East.

The study was conducted from 01.12. 2017 to 05.15.2019 at the School of Bio-Medicine of the Far Eastern Federal University (SBM FEFU), Pacific National Medical University (TSMU) of the Russian Federation, medical faculties of Harbin and Mudanjiang Universities (PRC). It was attended by 316 Russian and 302 Chinese students (total - 618 people with equal gender representation), the average age is 21.6 years. The average response rate was 92.8%.

Students who took part in the study completed the standardized questionnaire "Short form of self-assessment of the quality of life associated with the health of the MOS SF-36" (MOS SF - Medical Outcomes Study-Short Form). The study of mental status was carried out using scales of resilience (FS), social functioning (SF), emotional status (ES), psychological comfort (PC). The study of socio-economic status was carried out according to the Questionnaire Pozdeeva (2008) with the additions of the authors.

As a result of the study, it was found that the level of self-esteem of the psychological component of the quality of life related to health among Russian and Chinese medical students is within the range of standard values; Russian medical students rate psychological comfort higher, while their Chinese peers rate their own social functioning and resilience. Students of both samples showed a high level of correlation of the psychological component of the quality of life associated with health and academic performance. In addition, in both samples, the level of performance correlates with assessments of the conditions of study and living, as well as with individual characteristics of psychological status.

Keywords: psychological component of the quality of life; students; Russia; China; incidence; academic performance; socio-economic status.

For citation: Kuznetsov V.V., Kosilov K.V. A comparative analysis of the influence of psychological characteristics of quality of life and socio-economic status on academic performance of Russian and Chinese students of medical specialties in the neighboring territories of the far East. *Rossiiskii meditsinskii zhurnal (Medical Journal of the Russian Federation, Russian journal)*. 2019; 25(5-6): 287-292. (In Russ.)

DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-5-6-287-292>

For correspondence: Kirill V. Kosilov, doctor of medical sciences, professor of the Department of Social Sciences of the School of Arts and Humanities of the Far Eastern Federal University. 690922, Vladivostok, Russian Federation, E-mail: oton2000@mail.ru

Information about authors:

Kuznetsov V., <https://orcid.org/0000-0001-5320-5876>

Kosilov K., <https://orcid.org/0000-0001-9747-3100>

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Acknowledgments. The study had no sponsorship.

Received 18.11.19

Accepted 13.12.19

Актуальность

Качество жизни, связанное со здоровьем (КЖСЗ) является важным фактором, от которого – в том числе – зависит эффективность образовательного процесса студенческой молодежи, включая студентов медицинских направлений. Самооценка КЖСЗ, объективное состояние здоровья, социально-экономический статус влияют на эффективность образовательного процесса, мотивацию обучения, академическую успеваемость. Поэтому субъективная оценка здоровья студентами, его объективный статус и коррелирующие факторы социально-экономического состояния в настоящее время находятся в центре внимания исследователей и менеджеров общественного здравоохранения, социологов, психологов, экономистов, педагогических работников [1–4].

Хроническая соматическая заболеваемость в студенческой среде высока, и безусловно является предиктором эффективности обучения, однако многие авторы отмечают, что объективное состояние здоровья студентов, и его субъективное восприятие, ощущение, не являются тождественными, и последнее представляет собой самостоятельный фактор воздействия на эффективность образовательного процесса [5, 6]. Безусловно, негативное самочувствие, самоощущение студентов может снижать результат образовательного процесса, оптимальное качество жизни, связанное со здоровьем, напротив, повышать «отдачу», являться своеобразным катализатором успехов в обучении. В первую очередь, это может касаться психологической составляющей самочувствия, уровня психологического комфорта при нахождении в образовательном пространстве [7–9].

Известно, что медицинское образование имеет существенную специфику, связанную с интенсивными интеллектуальными нагрузками, часто избыточным психоэмоциональным напряжением. Принято считать, что, прежде всего это касается студентов-медиков первых курсов обучения, однако, многие исследователи отмечают, что на протяжении всего периода обучения будущие врачи сталкиваются с серьезными трудностями и проблемами при овладении профессиональными компетенциями, попадают в «затяжную» зону психологического дискомфорта [10,11]. В то же время, в текущей научной

литературе практически отсутствуют данные по анализу влияния субъективной самооценки психологического компонента качества жизни студентов медицинских направлений на успешность обучения, мотивацию к систематическим занятиям [12–15]. Особенно интересным могло бы стать проведение подобного анализа в кросс-культуральном аспекте, в межнациональных выборках. Подобный анализ позволил бы выделить ключевые факторы психологической самооценки, сопряженные с эффективностью обучения, не зависящие от этнических и региональных особенностей выборки.

Исходя из этих представлений мы сформулировали цель настоящего исследования: провести корреляционный анализ уровня самооценки психологических характеристик качества жизни, связанного со здоровьем, успеваемости и социально-экономического статуса и сопоставить его результаты у российских и китайских студентов медицинских специальностей сопредельных территорий Дальнего Востока.

Материал и методы

Данное исследование проводилось с 01.12.2017 по 15.05.2019 г. в Школе Биомедицины Дальневосточного Федерального Университета (ШБМ ДВФУ), Тихоокеанском Государственном медицинском университете (ТГМУ) Российской Федерации, медицинских факультетах Харбинского и Муданцзянского университетов (КНР). Отбор осуществлялся с использованием генератора случайных чисел методом стратифицированной по гендерному признаку рандомизации. В исследовании приняли участие 316 российских студентов и 302 китайских студента, всего 618 человек 301 (48,7%) девушка и 317 (51,3%) юношей. Средний возраст участников составил 21,6 лет. Средняя частота отклика составила 92,8%. Описательные демографические и социально-экономические переменные представлены в таблице. Критериями исключения были: академический отпуск, академическая задолженность на текущем курсе, наличие второго высшего образования.

Данные по семестровой успеваемости были получены из факультетских отчетов соответствующих университетов по итогам сессий. Информация о демографиче-

ском и социально-экономическом статусе, заболеваемости была собрана с использованием специальной анкеты (Поздеева, 2008; с дополнениями авторов). В данной анкете представлены блоки вопросов о демографическом, финансовом, социальном статусе, условиях проживания и обучения, качестве образовательного процесса, поведении в отношении здоровья, заболеваемости (открытый вопрос). Каждый вопрос анкеты оценивался в баллах от 0 (минимальное значение) до 5 (максимальное).

При самооценке психологического комфорта и благополучия студенты, принявшие участие в исследовании, заполняли стандартизированную анкету «Краткая форма самооценки качества жизни, связанного со здоровьем MOS SF-36» (MOS SF — Medical Outcomes Study-Short Form). Анкета MOS SF-36 переведена на русский и китайский языки, ее валидность доказана в предыдущих исследованиях. Изучение психического статуса проводится с использованием шкал жизнестойкости (ЖС), социального функционирования (СФ), эмоционального статуса (ЭС), психологического комфорта (ПК). Каждая шкала оценивается в диапазоне от 0 до 100 баллов. Среднее значение самооценок психологического статуса определяется как средняя суммарная оценка психологического компонента качества жизни, связанного со здоровьем респондента [5, 6].

Расчет объема выборочной совокупности проводился с учетом дисперсий подобных параметров в ранее проведенных исследованиях [5, 6, 8, 15–17]. При сопоставлении данных между средними значениями параметров считалась достаточной доверительная вероятность 95% и доверительный интервал $\pm 5\%$. Двусторонний анализ дисперсии (ANOVA) был применен при проверке до-

стоверности различий. Корреляция переменных оценивалась с использованием коэффициента Спирмена. Тест Вальда проводился для анализа корректности сравнения с неполным набором данных. Статистический анализ был проведен с использованием прикладной программы «Statistica 6.0».

Результаты

В 13 (2,1%) случаях полные анкетные данные у респондентов получить не удалось из-за ошибок при заполнении или/и отказа отвечать на какой-либо определенный вопрос (в 10 случаях — об индивидуальном и семейном доходе). Сопоставление полных и неполных данных по методу Вальда позволило подтвердить, что отсутствующая информация не влияет на достоверность сравнения.

Социально-экономические и демографические характеристики и параметры, связанные со здоровьем у российских и китайских студентов медицинских специальностей представлены в таблице. Среди российских студентов оказалось достоверно больше проживавших до поступления в ВУЗ в городских округах (68,26/38,3%, $p < 0,05$), значения остальных параметров в двух выборках достоверно не отличались. Средний уровень успеваемости в баллах среди китайских студентов составил 4,4 (0,2), среди российских — 4,2 (0,3), достоверных различий между выборками не было выявлено.

Самооценка психологических параметров качества жизни студентов медицинских специальностей в двух выборках представлена на рис. 1. Уровень жизнестойкости и эмоционального статуса китайские студенты оценивали несколько выше, чем их российские сверстники.

Социально-экономические и демографические характеристики и параметры, связанные со здоровьем у российских и китайских студентов медицинских специальностей (n=618)

Переменные	Российские студенты (n=316)		Китайские студенты (n=302)	
	M ¹	SD ¹	M	SD
Возраст	21,7	1,4	22,5	1,5
Ежемесячный индивидуальный доход ²	5,17	0,81	4,92	0,61
Ежемесячный доход домохозяйства ²	65,4	7,3	51,9	11,2
Условия проживания ³	3,6	0,5	4,2	0,7
Организационно-бытовые условия обучения ³	3,3	0,7	4,1	0,9
Качество питания ³	2,5	0,9	3,2	0,6
Число обращений к врачу за год ⁴	1,7	0,6	0,9	0,6
Употребление алкоголя ³	0,6	0,6	0,5	0,6
Курение (интенсивность) ³	2,3	0,7	2,8	0,4
Занятия спортом (эпизодов в неделю)	2,0	0,4	2,9	0,8
Дней пропуска по болезни за год ⁴	12,3	2,2	7,1	2,1
	N ⁵	%	N ⁵	%
Семейный статус (состоит в браке)	39	12,3	51	16,9
Наличие детей	20	6,3	34	11,2
Проживание в сельской местности	121	38,3	192	63,6*
Проживание в городском округе	195	61,7	110	36,4*

Примечание. ¹ Mean (M) — среднее значения показателя в выборке; SD (standard deviation) стандартное отклонение; ² — в тысячах рублей, для китайских студентов — по среднему курсу юаня к рублю на 2019 год; ³ — значение в баллах, от 1 до 5; ⁴ — в единицах; ⁵ — Number (N) число случаев; * $p < 0,05$.

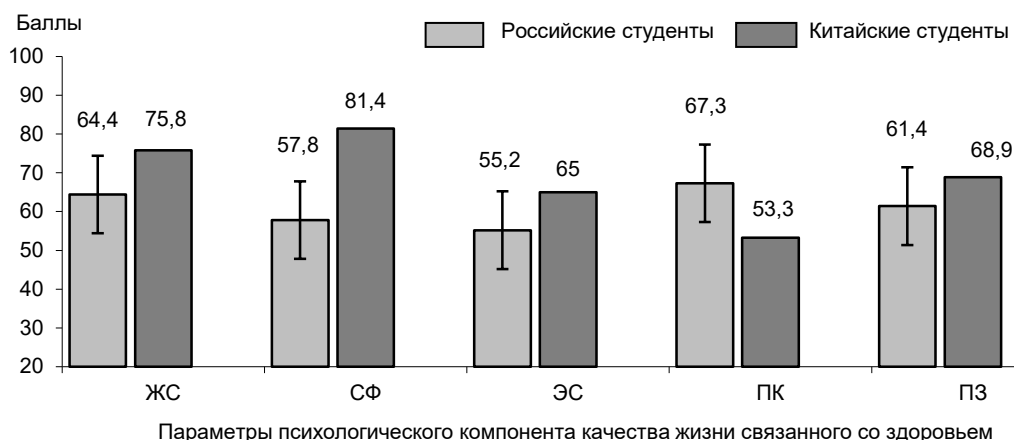


Рис. 1. Уровень самооценки психологического компонента качества жизни, связанного со здоровьем у российских ($n=316$) и китайских ($n=302$) студентов медицинских специальностей по вопроснику MOS SF-36v2.

Вопросник MOS SF-36v2 Health Status Survey - Short Form 36v2 - «Краткая форма самооценки качества жизни, связанного со здоровьем».

Подшкала психическое функционирование: жизнестойкость (ЖС), социальное функционирование (СФ), эмоциональный статус (ЭС), психологический комфорт (ПК). ПЗ — суммарная самооценка психологического здоровья (комфорта); Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 означает максимально позитивный ответ.

ки, однако различия оказались недостоверными (соответственно 75,8/64,4 баллов, $p>0,05$; 65,0/55,2 баллов, $p>0,05$). Значительно выше оказалась самооценка социального функционирования у китайских студентов 81,4 балла против 57,8 у российских, $p<0,05$. Единственный показатель психологического компонента качества жизни, который российские участники опроса оценили выше, чем их китайские сверстники — это собственно психологический комфорт: 67,3 баллов против 53,3, однако различия оказались недостоверными при сравнении между выборками ($p>0,05$). Суммарный уровень психологического здоровья у китайских студентов оказался выше, чем у российских, однако различия оказались статистически ничтожными ($p>0,05$).

На рис. 2 представлены результаты расчета регрессии значимости факторов, связанных с эффективностью обучения (семестровой успеваемостью). Композитный показатель психологического компонента КЖСЗ, по нашим данным коррелировал с успеваемостью ($r=3,6$ у россиян, 4,75 у китайцев), уровень влияния достоверно не отличался в национальных выборках. Среди наиболее сильно коррелирующих с успеваемостью отдельных показателей психологического здоровья можно отметить жизнестойкость у российских студентов-медиков ($r=6,9$), социальное функционирование и психологический комфорт у их китайских сверстников ($r=5,1$; 6,6). Среди прочих факторов, ассоциированных с успеваемостью, можно отметить высокий уровень корреляции показателя условий обучения в обеих выборках ($r=5,4$; 3,3).

Далее мы провели построение общей регрессионной модели, описывающей взаимосвязь успеваемости и ассоциированных факторов в объединенной выборке российских и китайских студентов. В процессе анализа полученных результатов удалось установить, что наиболее сильные взаимосвязи обучения отмечаются между показателем успешности обучения и такими факторами как суммарный психологический компонент КЖСЗ, оценками условий проживания и обучения.

Обсуждение

Основной задачей данного исследования была попытка выяснить, насколько взаимосвязана успеваемость студентов медицинских ВУЗов сопредельных территорий России и Китая с некоторыми факторами влияния, прежде всего качеством жизни, связанным с психологическим комфортом, уровнем адаптации образовательной среды, социально-экономическими условиями.

Мы установили, что при практически одинаковом уровне успеваемости, китайские студенты достоверно выше оценивают свой уровень социального функционирования, что может быть связано с более эффективными стратегиями адаптации в новой, непривычной социальной среде, формируемой в старших классах общеобразовательных школ [16, 17]. В то же время для российских студентов был характерен более высокий уровень психологического комфорта. Возможно, это связано с меньшими ожиданиями и запросами, связанными с образовательным процессом, однако не исключено, что подобная ситуация объясняется культурологическими особенностями или высокой мотивированностью к обучению, ясным целеполаганием, позволяющим нивелировать в индивидуальной ценностной иерархии какие-либо негативные эпизоды и процессы во время обучения [18–20].

В процессе построения регрессионной модели значимости влияния различных факторов на эффективность обучения было установлено, что суммарный показатель психологического компонента КЖСЗ, оказался связанным с успеваемостью, уровень взаимосвязи достоверно не отличался в национальных выборках. То есть высокая успеваемость отмечалась у тех российских и китайских студентов, которые оценивали свое психологическое здоровье и комфорт как оптимальные. Вероятно, при анализе причинно-следственных связей, может возникнуть сомнение: не является ли комфортное психологическое состояние следствием успехов в освоении специальности, а не предиктором этих достижений?

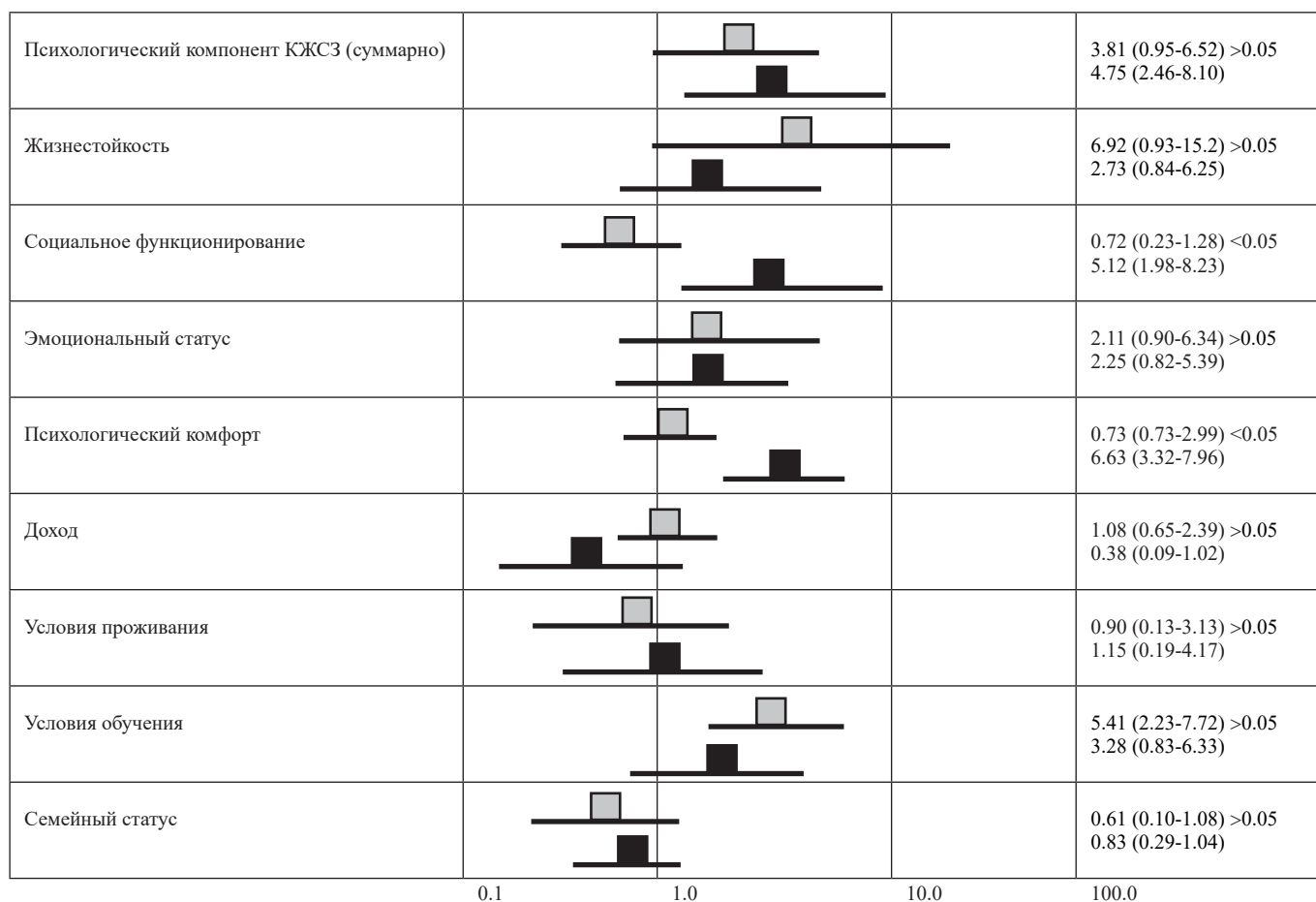


Рис. 2. Регрессионная модель: факторы, ассоциированные с успеваемостью для выборок российских ($n=316$; серые маркеры) и китайских ($n=302$; черные маркеры) студентов медицинских специальностей.
КЖСЗ — качество жизни, связанное со здоровьем, композитная оценка.

Однако в процессе работы были также выявлены корреляции высокой успеваемости с условиями обучения, частично — с комфортом социально-бытовых условий. Поэтому более рационально, на наш взгляд, выглядит предположение, что оптимальные социально-бытовые условия, комфорт образовательного пространства детерминируют пребывание студентов обоих выборок в зоне психологического оптимума, что в свою очередь приводит к более эффективным образовательным стратегиям и повышению успеваемости.

Безусловно, данное исследование не свободно от ограничений. Мы не проводили сравнительный анализ корреляции объективной заболеваемости у студентов с самооценкой психологического здоровья.

Результаты данной работы могут быть востребованы специалистами лечебно-профилактических учреждений, прикрепленных к ВУЗам, социологами и психологами, изучающими самооценку студентами своего психологического и физического здоровья, а также педагогами высшего образования.

Выводы

1. Уровень самооценки психологического компонента качества жизни, связанного со здоровьем у российских и китайских студентов медицинских направлений,

находится в пределах диапазона нормативных значений, и достоверно не отличается. Суммарный показатель у китайских студентов несколько превышает таковой у студентов российских медицинских университетов.

2. Российские студенты-медики выше оценивают психологический комфорт, в то время как их китайские сверстники дают более высокую оценку собственному социальному функционированию и жизнестойкости.

3. У студентов обоих выборок отмечается высокий уровень корреляции психологического компонента качества жизни, связанного со здоровьем с успеваемостью.

4. Показатель семестровой успеваемости в российской и китайской выборках коррелирует с оценками условий обучения и проживания, а также отдельными характеристиками психологического статуса.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бобылева О.В. Состояние здоровья студенческой молодежи как социально-экологическая проблема. *Вестник ТГУ*. 2013; 18(3): 852-4.
2. Журавлева И.В., ред. *Здоровье студентов: социологический анализ*. М.: Институт социологии РАН. 2012.

REFERENCES

- Бабина В. С. Проблемы здоровья студенческой молодежи. *Молодой ученый*. 2015; 11: 572-5.
- Били-Лазарь А.А., Хлебутина Э.В., Вольский В.В. Причины ухудшения состояния здоровья студенческой молодежи. *Успехи современного естествознания*. 2013; 10: 192.
- Корниенко Д.С., Козлов А.И., Отавина М.Л. Взаимосвязь самооценок здоровья и психологического благополучия у практически здоровых и имеющих хронические заболевания молодых людей. *Гигиена и санитария*. 2016; 6: 577-81.
- Ирихин Н.В., Журавлев Ю.И., Жернакова Н.И., Чефранова Ж.Ю., Ирихина И.В. Сравнительный анализ объективной и субъективной оценок здоровья студентов в ходе реализации инновационной образовательной программы «Здоровьесбережение». *Вестник ТГУ*. 2009; 6 (74): 49-53.
- Картышева С.И., Попова О.А., Грошева Е.С. Самооценка здоровья и образа жизни студентов педагогического университета. *Гигиена и санитария*. 2015; 9:18-20.
- Алексеев С.Н., Дробот Е.В. Категории жизнестойкости и качества жизни у студентов медицинского ВУЗа в сопряженности с самооценкой здоровья. *Земской врач*. 2014; 2(23): 41-4.
- Бянкина Л.В., Изотова В.М., Хотимченко А.В., Цуман Н.А. Самооценка здоровья студентами профессиональных учебных заведений Хабаровска как составляющая их психофизиологического состояния. *Научно-теоретический журнал «Ученые записки»*. 2014; 4(110): 24-8.
- Трапезникова М.В., Савкин В.В. Мониторинг и прогнозирование психофизиологического статуса и успеваемости студенток I-II курса медицинского вуза. *Гигиена и санитария*. 2015; 1: 104-7.
- Lyndon M, Henning M., Alyami H., Krishna S., Yu T.-C. And Hill A. The Impact of a Revised Curriculum on Academic Motivation, Burnout, and Quality of Life among Medical Students. *Journal of Medical Education and Curricular Development*. 2017; 4: 1-8.
- Boni R.A., Paiva C.E., Marco Antonio de Oliveira M.A., et al. Burnout among medical students during the first years of undergraduate school: Prevalence and associated factors. *PLoS One*. 2018; 13(3): e0191746.
- Влах Н.И. Особенности синдрома профессионального выгорания у представителей медицинских профессий. *Вестник ЮУрГУ*. 2017; 10(1): 5-11.
- Кустова В.В. Синдром эмоционального выгорания и его профилактика у студентов — социальных педагогов. Дис. канд. псих. наук. 2007; Иркутск.
- Попов В.И., Мелихова Е.П. Изучение и методология качества жизни студентов. *Гигиена и санитария*. 2016; 9: 879-87.
- Qiu Y., Yao M., Guo Y., Zhang X., Zhang S., Zhang Y., et al. Health-Related Quality of Life of Medical Students in a Chinese University: A Cross-Sectional Study. *International Journal Environmental Research of Public Health*. 2019; 16(24): pii: E5165.
- Zhang G.B., Xu N., Han A.Z., Xie G.D., Chen L.R., Su P.Y. Association between suffering experiences from precollege peer bullying at different stages and the quality of health-related life among college students. *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi*. 2019; 40 (8): 965-70.
- Мартыненко О.О., Коротина О.А. Ценностные ориентации студенческой молодежи. *Высшее образование в России*. 2016; 8-9: 22-9.
- Малахаева С.К., Уварова М.Ю., Кедярова Е.А. Исследование ценностных ориентаций российских студентов, обучающихся в Китае. *Байкальский исследовательский журнал*. 2017; 8 (4):1-10.
- Лепихин В. В., Лепихина Т. Л., Карпович Ю. В. Влияние формальных и неформальных институтов на формирование рациональных моделей здоровьесберегающего поведения студентов. *Вестн. ПНИПУ. Безопасность и управление рисками*. 2015; 2: 136-45.
- Bobyleva O. V. Health status of students as a socio-environmental problem. 2013. *Vestnik TGU*. 2013; 18(3) : 852-4. (in Russian)
- Zhuravleva I.V., ed. Student health: a sociological analysis. M.: Institute of Sociology RAS. 2012. (in Russian)
- Babina V.S. Health problems of student youth. *Molodoy uchenyy*. 2015; 11: 572-5. (in Russian)
- Bili-Lazar A.A., Khlebutina E.V., Volsky V.V. The reasons for the deterioration of the health status of student youth. *Successes in modern science*. 2013; 10:192. (in Russian)
- Kornienko D.S., Kozlov A.I., Otavina M.L. The relationship of self-esteem of health and psychological well-being in healthy young people with chronic diseases. *Gigiena i sanitariya*. 2016; 6:577-81. (in Russian)
- Irikin N.V., Zhuravlev Yu.I., Zhernakova N.I., Chefranov Zh.Yu., Irikhina I.V. A comparative analysis of the objective and subjective assessments of students' health in the course of the implementation of the innovative educational program "Health Care". *Vestnik TGU*. 2009; 6 (74):149-53. (in Russian)
- Kartisheva S.I., Popova O.A., Grosheva E.S. Self-assessment of the health and lifestyle of students of the Pedagogical University. *Gigiena i sanitariya*. 2015; 9:S.18-20. (in Russian)
- Alekseenko S.N., Drobot E.V. Categories of vitality and quality of life among students of a medical university in conjunction with a self-esteem of health. *Zemsky doctor*. 2014; 2 (23): 41-4. (in Russian)
- Byankina L.V., Izotova V.M., Khotimchenko A.V., Tsuman N.A. Self-esteem of health by students of professional educational institutions of Khabarovsk as a component of their psychophysiological state. *Nauchno-teoreticheskiy zhurnal «Uchenye zapiski»*. 2014; 4 (110): 24-8. (in Russian)
- Trapeznikova M.V., Savkin V.V. Monitoring and forecasting the psychophysiological status and performance of students of the I-II year of medical school. *Gigiena i sanitariya*. 2015; 1: 104-7. (in Russian)
- Lyndon M, Henning M., Alyami H., Krishna S., Yu T.-C., Hill A. The Impact of a Revised Curriculum on Academic Motivation, Burnout, and Quality of Life among Medical Students. *Journal of Medical Education and Curricular Development*. 2017; 4: 1-8.
- Boni R.A., Paiva C.E., Marco Antonio de Oliveira M.A., et al. Burnout among medical students during the first years of undergraduate school: Prevalence and as-associated factors. *Plos one*. 2018; 13 (3): e0191746.
- Vlakh N.I. Features of burnout syndrome among representatives of medical professions. *Bulletin of UUGU*. 2017; 10:(1): 5-11. (in Russian)
- Kustova V.V. *Burnout syndrome and its prevention among students*. Dis. kand. psihol. nauk. 2017; Irkutsk. (in Russian)
- Popov V.I., Melikhova E.P. Studying and methodology of quality of life of students. *Gigiena i sanitariya*. 2016; 9: 879-87. (in Russian)
- Qiu Y., Yao M., Guo Y., Zhang X., Zhang S., Zhang Y., et al. Health-Related Quality of Life of Medical Students in a Chinese University: A Cross-Sectional Study. *International Journal Environmental Research of Public Health*. 2019; 16(24): pii: E5165.
- Zhang G.B., Xu N., Han A.Z., Xie G.D., Chen L.R., Su P.Y. Association between suffering experiences from precollege peer bullying at different stages and the quality of health-related life among college students. *Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi*. 2019; 40 (8): 965-70.
- Martynenko O.O., Korotina O.A. Value orientations of students. *Vyshee obrazovanie v Rossii*. 2016; 8-9: 22-9. (in Russian)
- Malakhaev S.K., Uvarova M.Yu., Kedyarova E.A. A study of the value orientations of Russian students studying in China. *Baykal'skiy issledovatel'skiy zhurnal*. 2017; 8 (4):1-10. (in Russian)
- Lepikhin V.V., Lepikhina T.L., Karpovich Yu.V. Influence of formal and non-formal institutions on the formation of rational models of students' health-saving behavior. *Vestnik PNIPU. Bezopasnost' i upravlenie riskami*. 2015; 2: 136-45. (in Russian)

Поступила 18.11.19
Принята к печати 13.12.19